초고위험 골다공증: 약제 선택·급여 서류·의뢰 확인표

임상적인 초고위험 분류와 강의에서 소개한 국내 골형성촉진제 급여 조건을 나누어 검토한다.

핵심 판단 한눈에

초고위험
최근·다발골절 등

→

골형성촉진제 우선
Anabolic first

→

골흡수억제제
후속 치료 연결

초고위험군은 골형성촉진제를 먼저 고려하고 이후 골흡수억제제로 연결한다.

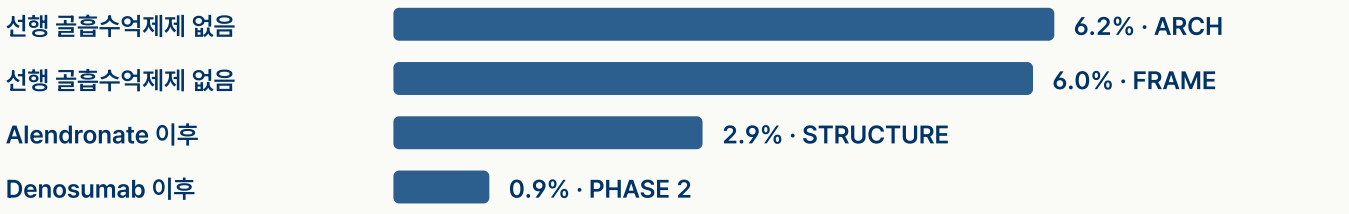
초고위험 단서 · 강의 표

- ☐ 최근 **12개월 내 취약골절**, 치료 중 골절, 다발골절, 뼈에 나쁜 약제 사용 중 골절
- ☐ T점수 **<−3.0**, 높은 낙상 위험
- ☐ FRAX 10년 위험도: 고관절 **≥4.5%** 또는 주요 골다공증 골절 **≥30%**

고위험군과 초고위험군을 구분

고위험군 · 강의 표	초기치료 소개
취약골절 또는 T ≤−2.5, FRAX 10년 고관절 ≥3% 또는 주요골다공증 골절 ≥20%	Alendronate·denosumab·risedronate·zoledronate. Ibandronate·raloxifene은 척추 중심 효과

순차치료의 효과 · 강의가 소개한 연구별 수치



Romosozumab 1년 총대퇴골 BMD 변화. 서로 다른 연구의 수치이다.

골형성촉진제를 먼저 고려하는 이유

골흡수와 골형성의 짝짓기 (coupling)

골흡수억제제의 장기 사용으로 골흡수뿐 아니라 골형성도 감소한다. 강의는 이후 골형성촉진제 반응이 줄어드는 점을 설명했다. 최근 골절 후 재골절 위험은 강의 발언에서 1–2년 내 약 5배, 다발골절은 추가 80%를 소개했다.

초고위험 골다공증 급여 서류·의뢰 체크

강의가 제시한 급여 조건과 연자 Q&A의 개별 상황을 함께 검토한다.

골형성촉진제 급여 · 강의 표의 동시 충족 조건

확인 자료	Teriparatide / Romosozumab
선행 약제	골흡수억제제 ≥1가지가 효과 없거나 사용 불가. 효과 없음: 1년 이상 충분히 투여했음에도 새로운 골절 발생
연령·성별	65세 이상 / Romosozumab은 폐경 후 여성
중심골 DXA	요추·대퇴(Ward's triangle 제외) DXA T-score ≤−2.5 SD
골절 증빙	골다공증성 골절 ≥2개. 과거 골절의 자료 첨부
투여기간 · 강의 표	Teriparatide: 최대 24개월, 일생에서 24개월 과정 반복 불가. Romosozumab: 1개월 간격 총 12회
교체투여 · 강의 표	Teriparatide acetate 주사제(테리본피하주사)와 교체투여는 급여로 인정하지 않음

연자 Q&A · 개별 상황의 약제 선택

암 병력 · 치료 종료 뒤의 골절 위험

Q&A 89쪽: 림프종 항암치료 병력 환자의 romosozumab 전환 질문에는, 암환자에서 골형성촉진제 안전성을 이유로 denosumab 유지를 답변했다.
Q&A 92쪽: 골밀도 호전 뒤에도 고령·다발골절·낙상 위험이 높으면 유지 가능성을 판단한다. 충분히 위험이 낮아지면 bisphosphonate로 마무리한다고 설명했다.

전문 클리닉에 함께 전달할 자료

- ☐ 골절 날짜·부위·원영상·판독, 과거 골절 증빙을 모은다.
- ☐ 중심골 DXA와 선행 약제명·기간, 새 골절·사용 불가 사유를 정리한다.
- ☐ 암 치료력·낙상 위험, 약물의 효과·부작용·복약 편의성·가격을 함께 살핀다.
- ☐ 골형성촉진제 이후 골흡수억제제 계획을 함께 세운다.

골형성촉진제가 필요한 초고위험군

전문 클리닉 의뢰

강의의 폐경 후 골다공증 알고리즘은 초고위험군의 전문 클리닉 의뢰를 제시했다. 임상 위험에 맞는 초기 약제 선택과 급여 조건 충족 여부를 함께 전달한다.